

Táo bón là tình trạng đi cầu **không thường xuyên, phân cứng hoặc khó đi**. Đây là vấn đề rất phổ biến — và ảnh hưởng đến sức khỏe vùng chậu vì **việc rặn mạnh** làm nặng thêm sa tạng chậu, tiểu không kiểm soát và đau vùng chậu. Tin tốt là hầu hết táo bón có thể cải thiện với các thay đổi đơn giản và hiệu quả.

Về tình trạng này

Đi cầu bình thường không cần phải rặn. Dấu hiệu táo bón gồm: đi ít hơn ba lần mỗi tuần, phân cứng hoặc vón cục, phải rặn mạnh, cảm giác **đi không hết**, hoặc cần dùng tay ấn vào vùng âm đạo hoặc trực tràng để đi cầu ("đỡ phân").

Nguyên nhân

- **Ít chất xơ và nước**, ít vận động
- **Bỏ qua cảm giác muốn đi cầu**
- **Thuốc** — opioid, sắt, và một số loại khác
- **Rối loạn cơ sàn chậu** — các cơ không giãn ra để đẩy phân ra ("táo bón đầu ra")
- Ruột co bóp chậm

Táo bón "đầu ra" quan trọng cần lưu ý: cần điều trị bằng **vật lý trị liệu sàn chậu**, không chỉ dùng thuốc nhuận tràng.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Táo bón

Đi cầu không thường xuyên, phân cứng hoặc khó đi.

Chất xơ

Thành phần từ thực vật giúp làm mềm và tăng khối lượng phân.

Thuốc nhuận tràng thẩm thấu

Thuốc nhẹ (như PEG) hút nước vào trong phân.

Táo bón đầu ra

Khó đi cầu do cơ sàn chậu không giãn được.

Biofeedback

Liệu pháp tập lại cho cơ biết cách giãn khi đi cầu.

Đỡ phân

Dùng tay ấn gần âm đạo hoặc trực tràng để giúp phân đi ra.

TẠI SAO BÁC SĨ TIẾT NIỆU LẠI QUAN TÂM? Vì rặn khi đi cầu tạo áp lực lên cùng hệ thống nâng đỡ bàng quang và các tạng vùng chậu — do đó táo bón làm nặng thêm sa tạng và tiểu không kiểm soát, và trực tràng đầy phân có thể chèn ép bàng quang. Điều trị táo bón thường cải thiện cả triệu chứng tiểu tiện.

Điều trị như thế nào (từng bước)

- 1 Chất xơ, nước và vận động** — tăng chất xơ dần dần (từ thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung) cùng với uống đủ nước.
- 2 Thói quen vệ sinh** — đi khi có cảm giác muốn đi, dùng **ghế kê chân** để nâng cao đầu gối (tư thế ngồi xổm), và **không rặn mạnh**.
- 3 Thuốc nhuận tràng nhẹ** — thuốc thẩm thấu (như PEG) an toàn khi dùng thường xuyên nếu cần.
- 4 Vật lý trị liệu sàn chậu / biofeedback** cho táo bón đầu ra; và xem lại các thuốc có thể gây táo bón với nhóm chăm sóc.

Thói quen lành mạnh

- Cố gắng đi vệ sinh **đúng giờ mỗi ngày**, thường sau bữa ăn.
- Dành thời gian thoải mái; không gắng sức hay rặn mạnh.
- Duy trì vận động — đi bộ hàng ngày cũng giúp ruột co bóp tốt hơn.

Điều nên biết

- Tăng chất xơ **từ từ** để tránh đầy bụng, và uống đủ nước kèm theo.
- Thuốc nhuận tràng kích thích có thể dùng thỉnh thoảng; hỏi bác sĩ trước khi dùng hàng ngày.
- Nếu rặn là vấn đề chính, nguyên nhân có thể do phối hợp cơ kém — điều trị vật lý trị liệu hiệu quả hơn dùng thêm thuốc nhuận tràng.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Máu trong phân** hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân
- Táo bón mới xuất hiện không cải thiện, đặc biệt ở người lớn tuổi
- Đau bụng dữ dội, nôn mửa, hoặc **không đánh hơi hoặc không đi cầu được** (có thể tắc ruột)

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Táo bón phổ biến và ảnh hưởng đến sức khỏe vùng chậu — rặn mạnh làm nặng thêm sa tạng và tiểu không kiểm soát.
- Điều trị bằng chất xơ, uống đủ nước, vận động, thói quen vệ sinh tốt (dùng ghế kê chân, không rặn) và thuốc nhuận tràng nhẹ khi cần.
- Nếu còn rặn mạnh, hỏi về vật lý trị liệu sàn chậu. Báo ngay nếu có máu trong phân, sụt cân, hoặc thay đổi đột ngột nghiêm trọng.